

Setki reguł, jedna funkcja — *utrzymać kontrolę*

Sztuczne zasady „co wolno, czego nie, ile, kiedy” tworzą architekturę AN. Identyfikujemy je, sprawdzamy ich funkcję, łamiemy stopniowo.

CZAS: 30 min identyfikacji + miesiące pracy

REALIZACJA: faza 2 CBT-E (sesje 8-16), po ustabilizowaniu regularnego jedzenia

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 7-8); Waller i in. (2007, rozdz. 7); Cooper & Fairburn (2011, *Int J Eat Disord*); Polivy & Herman (1985, *restrained eating*)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery mechanizmy**, dlaczego reguły żywieniowe podtrzymują AN (poznawcze obciążenie, poczucie kontroli, generowanie lęku, restrykcja). Sekcja 02 — **dziewięć kroków** dekonstrukcji: od identyfikacji do eksperymentu behawioralnego i monitorowania „nowych reguł”. Sekcja 03 — **arkusz „Moje reguły”** do wypełnienia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Reguły żywieniowe (ang. *dietary rules*) — sztuczne zakazy i nakazy („nie po 18:00”, „bez węglowodanów”, „tylko sam/-a”) podtrzymujące AN. Fairburn (2008) wyróżnia *jakościowe* (co wolno) i *ilościowe* (ile). Mechanizm: obciążenie poznawcze + poczucie kontroli + lęk przy naruszeniu + nośnik restrykcji. Praca: identyfikacja, kategoryzacja, sprawdzenie funkcji, eksperymenty behawioralne (każda reguła naruszana 5-10 razy dla habituacji). Uwaga na *nowe* reguły zastępujące zburzone (efekt odbicia — ang. *rebound*).

01 Cztery mechanizmy — jak reguły podtrzymują AN

MECHANIZM

CO SIĘ DZIEJE I DLACZEGO UTRZYMUJE AN

1 · Obciążenie poznawcze	Pacjent „śledzi” 15-30 reguł jednocześnie — co wolno, ile, kiedy, gdzie, z kim. Zasoby mentalne zużywane na <i>przestrzeganie</i> , nie na życie. Inne sfery (relacje, praca, zainteresowania) ulegają zaniedbanu.
2 · Poczucie kontroli	Każda przestrzegana reguła = „mam to pod kontrolą”. To kluczowy element ego-syntonii AN: zaburzenie nie czuje się jak choroba, tylko jak „silna wola”. Reguły są dowodem na „moje zdolności”.
3 · Lęk przy naruszeniu	Każde „złamanie” reguły = intensywny lęk („przytyję, stracę kontrolę, będę gorszy/-a”). To wzmacnia unikanie → reguła pozostaje. Klasyczna pętla unikania, analogiczna do fobii.
4 · Nośnik restrykcji	Reguły <i>nie</i> są tylko konsekwencją restrykcji — są jej nośnikiem. „Nie po 18:00” oznacza brak kolacji = mniej kalorii. „Bez węglowodanów” = restrykcja całej grupy. Bez reguł — restrykcja nie ma na czym się oprzeć.

Reguły jakościowe vs ilościowe. Jakościowe: CO wolno (lista produktów). Ilościowe: ILE (liczba porcji, gramów, kalorii). U różnych pacjentów dominuje inny typ — sprawdź oba. Często współwystępują.

02 © Dziewięć kroków dekonstrukcji (Fairburn, 2008)

1. **Identyfikacja — burza mózgów:** „Wypisz wszystkie zasady dotyczące jedzenia. Kiedy można? Czego nie? Ile? Gdzie? Z kim? Jak?” Cel: 15–30 reguł. Niektóre będą zaskoczeniem dla samego pacjenta.
2. **Kategoryzacja** — (a) jakościowe (co wolno) vs ilościowe (ile); (b) sztywne (zawsze) vs elastyczne (czasem); (c) społeczne (z kim, gdzie) vs prywatne.
3. **Funkcja każdej reguły** — „Do czego Ci służy? Przed czym Cię chroni?” Przykład: „nie jem po 18:00” — funkcja: „chronię się przed tym, mam poczucie kontroli”. Funkcja to nie „dobre/złe” — to cel.
4. **Sprawdzenie empiryczne** — „Co dokładnie się stanie, gdy złamiesz regułę?” Pacjent często mówi „katastrofa” — ale konkretnie? „Przytyję” — o ile? „Stracę kontrolę” — w jaki sposób? Czasem reguła chroni przed fikcyjną konsekwencją.
5. **Hierarchia trudności** — uporządkuj reguły od najłatwiejszej do złamania (lęk 0–10) do najtrudniejszej. Zaczynaj od „4–5”, nie od „9–10”. Strefa wyzwania, ale wykonalności.
6. **Eksperyment behawioralny** — wybierz regułę „5”, zaprojektuj eksperyment: „W piątek zjem śniadanie przy innych (zamiast samemu)”. Przed: „Co przewiduję?” Po: „Co naprawdę się stało?” Zwykle: znacznie mniej groźne niż przewidywał.
7. **Powtarzanie** — każdą regułę trzeba naruszyć wielokrotnie (minimum 5–10 razy), żeby uczucie „zagrożenia” osłabło (habitualizacja). Jednorazowe naruszenie nie wystarcza.
8. **Uogólnienie** — po zburzeniu kilku reguł pacjent zaczyna widzieć wzorzec: „moje reguły chroniły mnie przed fikcyjnymi zagrożeniami. Mogę zaufać zdrowym sygnałom ciała”. Generalizacja jest celem terapii.
9. **Uwaga na nowe reguły** — pacjenci często „wymieniają” reguły: stara znika, nowa się pojawia (efekt odbicia — ang. rebound). Monitorowanie: „Czy pojawiają się nowe zasady?” To objaw, że trzeba pracować z funkcją AN, nie tylko z pojedynczymi regułami.

03 Moje reguły — arkusz pracy

REGUŁA („NIE WOLNO X” I „MUSZĘ Y”)	FUNKCJA — PRZED CZYM CHRONI	LĘK 0–10	EKSPERYMENT DO ZAPLANOWANIA
------------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------

Klucz: najtrudniejsze reguły to te „niewidzialne” — zautomatyzowane. Pacjent może nawet *nie* wiedzieć, że je ma. Przykład: „tylko z białego talerza” — ujawnione przypadkowo. Eksperyment „zjedz z innego talerza” może wyzwolić panikę. To jest *właśnie* praca. Im bardziej „niewidoczna” reguła, tym głębsza jest kontrola AN. **Komunikat dla pacjenta:** „nie wszystkie reguły są oczywiste. Czasem dowiadujemy się o nich przez przypadek — gdy coś idzie inaczej niż „zwykle” i pojawia się lęk. To dobry znak, że odkryliśmy kolejną”.

⚠ **Refeed restrykcyjnych pacjentów:** u pacjentów z bardzo niską masą ciała eksperymenty behawioralne (np. „zjedz X, którego unikasz”) muszą być koordynowane z procesem rehabilitacji żywieniowej i monitorowaniem medycznym. „Złamanie reguły” w sensie poznawczym nie może oznaczać niekontrolowanego wprowadzania dużych ilości fear food bez zaplanowania — to ryzyko refeeding syndrome u skrajnie niedożywionych pacjentów.